

약제 요양급여의 적정성 평가결과

Rilpivirine 25mg

(에듀란트정25밀리그램, (주)한국얀센)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1정 중 rilpivirine 25mg

☐ 효능 효과 :

- 항레트로바이러스 치료 경험이 없는 성인 환자의 제 1형 인간면역결핍 바이러스 (HIV-1) 감염 치료를 위한 다른 항레트로바이러스제와의 병용요법

☐ 약제 급여 평가 위원회 심의 일

2012년 제10차 약제급여평가위원회: 2012년 8월 30일

- 중암심사평가조정위원회 심의일: 2012년 6월 18일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다

가. 평가 결과

□ 최종결과

○ 제약사가 ■■■원 이하를 수용하였으므로 급여의 적정성이 있음.

※ 2012년 10차 약제급여평가위원회평가결과: 비급여

- 신청품은 “항레트로바이러스 치료 경험이 없는 성인 환자의 HIV-1 감염 치료를 위한 다른 항레트로바이러스제와의 병용요법”에 허가받은 약제로 대체약제(NNRTI 계열)인 efavirenz와 비교 시 효과면에서 비열등하고 안전성 측면에서 신경·정신학적 부작용 및 발진 발생이 감소되었으므로 임상적 유용성 개선이 인정되나, 대체약제 대비 투약비용이 고가로 이에 상응하는 비용 효과성이 입증되지 않았으므로 비급여함.
- 단, 제약사가 대체약제의 가중평균가로 환산된 금액(■■■원/정) 이하를 수용할 경우, 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “항레트로바이러스 치료 경험이 없는 성인 환자의 HIV-1 감염 치료를 위한 다른 항레트로바이러스제와의 병용요법”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 허가 받은 비뉴클레오시드 역전사효소 억제제(NNRTI)인 efavirenz, nevirapine 등이 등재되어 있으므로 대체가능성을 고려 시 진료 상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 비뉴클레오시드 역전사효소 억제제 계열(NNRTI)의 항레트로바이러스제로 efavirenz 대비 효과는 비열등하고 발진 및 중추신경계 부작용 발생율은 낮은 약제임¹⁾²⁾
- 치료 경험이 없는 HIV-1 감염 치료에 신청품은 NNRTI 계열을 포함한 병용요법에 alternative regimen 또는 acceptable regimen으로 추천되고 있음³⁾.
- 18세 이상, 혈장 바이러스량 5000 copies/ml 이상, 치료 경험이 없는 HIV-1 감염환자(N=690)를 대상으로 한 제 3상 무작위 배정, 이중맹검, 다기관 임상시험⁴⁾에서 tenofovir-disoproxil-fumarate + emtricitabine을 background regimen으로 하고 신청품(rilpivirine 25mg qd)과 efavirenz(600mg qd)를 투여한 결과, 48주째 반응율⁵⁾은 비열등하였고(-0.4, 95% CI -5.9~5.2; p<0.0001, 비열등성 입증 한계 12%) 바이러스학적 실패율은 신청품 군에서 높았음. 부작용 평가 결과 grade 2 이상의 이상반응⁶⁾ 발생율은 신청품 군에서 유의하게 낮았으며(16% vs 31%, p<0.0001), 신경학적 부작용⁷⁾ 발생율(신

청품(ril) 16% vs efavirenz(efa) 37%; $p<0.0001$) 및 정신학적 부작용⁸⁾ 발생률도 유의하게 낮았음(ril 15% vs efa 25%; $p=0.0006$).

▪ Baseline viral load에 따른 반응을 비교

Viral load(copies/ml)	Rilpivirine 군	Efavirenz 군
$\leq 100,000$	90%(162/181)	83%(136/163)
$>100,000 \sim \leq 500,000$	79%(104/131)	83%(111/134)
$>500,000$	62%(21/34)	81%(38/47)

- 18세 이상, 혈장 바이러스량 5000 copies/ml 이상, 치료 경험이 없는 HIV-1 감염환자 (N=680)를 대상으로 한 제 3상 무작위 배정, 이중맹검, 다기관 임상시험⁹⁾에서 세 가지 NRTI regimen을 background로 하고 신청품(rilpivirine 25mg qd)과 efavirenz(600mg qd)를 투여한 결과, 신청품은 efavirenz 대비 48주째 반응률¹⁰⁾에서 비열등하였고(3.9%, 95% CI -1.6~9.5; $p<0.0001$) 바이러스학적 실패율은 신청품 군에서 높았음. 안전성 평가 결과 grade 2 이상의 이상반응¹¹⁾ 발생률은 신청품 군에서 유의하게 낮았고(16% vs 31%, $p<0.0001$), 신경학적 부작용¹²⁾ 발생률(ril 18% vs efa 39%; $p<0.0001$) 및 정신학적 부작용¹³⁾ 발생률(ril 15% vs efa 20%; $p=0.09$)도 신청품 군에서 낮았음.

▪ Baseline viral load에 따른 반응을 비교

Viral load(copies/ml)	Rilpivirine 군	Efavirenz 군
$\leq 100,000$	91%(170/187)	84%(140/167)
$>100,000 \sim \leq 500,000$	80%(94/118)	82%(112/136)
$>500,000$	77%(27/35)	69%(24/35)

- 무작위 배정, 3상 임상시험인 ECHO와 THRIVE에서 바이러스학적 실패(VF)를 보인 환자의 HIV-isolate 분석 결과¹⁴⁾, VF 발생률은 rilpivirine 군에서 유의하게 높았으며(10% vs 6%; $p=0.0014$), baseline VL 100,000 copies/ml를 기준으로 subgroup 분석 결과 100,000 이하인 경우는 두 군에서 VF 발생률이 5%로 같았으나, 초과하는 경우 RPV 군에서 유의하게 높았음(17% vs 7%; $p<0.0001$)
- 신청품의 허가사항 중 사용상 주의사항에 따르면 신청품 투여 시 기저상태의 바이러스 부하가 100,000 copies/ml을 초과하는 환자의 경우 그 이하인 환자와 비교하여 바이러스학적 실패의 위험이 크므로 치료 시작 시 이러한 사항이 고려되어야 함.
- 에이즈 환자의 경우 다양한 신체적 또는 정신적 문제를 가지고 있어 환자에게 약제를 투여할 때 다양한 요인을 고려하여 최적의 병합용법을 임상 전문가가 처방함¹⁵⁾.
 - 신청품은 기존 에이즈 치료제와 비교하여 신경·정신학적 이상반응 발현율이 개선된 것으로 알려져 높은 우울감을 가지고 있는 경우 기존의 NNRTI 계열의 약물을 대체하거나 우선적으로 사용할 수 있으며, 이상지질혈증이 있는 환자 또는 심혈관계 질환이나 위험요인을 가진 환자에게도 우선적으로 사용할 수 있음.

- Pill-burden이 적은 장점(작은 크기의 알약을 하루 1번 1정 복용)이 있어 복용 순응도가 낮을 것으로 예상되는 위험요인(낮은 교육, 낮은 사회적 지지)을 가진 환자군에서도 처방에 유리할 것이라는 의견임.

- 신청품은 항레트로바이러스 치료 경험이 없는 환자에게 초치료로 사용하였을 경우 부작용이 적고 안전하게 사용할 수 있기 때문에 국내에서 반드시 사용이 필요한 약제임¹⁶⁾.

○ 비용 효과성

- 항레트로바이러스 요법(antiretroviral therapy)에 허가받은 NNRTI 계열 약제인 efavirenz, nevirapine을 신청품의 대체약제로 선정함.
- 신청품의 일일투약비용은 ■■■■■원, 대체약제의 가중일일 투약비용은 ■■■■■원임.
- 신청품은 efavirenz 대비 48주째 반응율이 비열등하고 신경·정신학적 부작용 및 발진 발생율을 감소시킨 점 등을 고려 시 임상적 유용성 개선이 인정되므로 경제성평가 대상에 해당함.
- 제약사에서는 대체가능 약제들과의 비용-최소화 분석 자료를 제출하였으나 비교약제 선정 등이 경제성평가 지침¹⁷⁾에 따라 이루어지지 않았음.

○ 재정 영향¹⁸⁾

1) 신청약가 기준

- 해당적응증의 대상 환자수¹⁹⁾는 ■■■■명이고, 제약사 제출 예상사용량²⁰⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²¹⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, efavirenz, nevirapine 대체로 재정소요금액은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원 증가될 것으로 예상됨²²⁾.

2) 대체약제 가중평균가로 환산된 가격기준

- 제약사 제출 예상사용량²³⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액²⁴⁾은 1차년도에 약 ■■■■원, 3차년도에 약 ■■■■원이 되고, 신청품의 도입 후 efavirenz, nevirapine의 대체로 인한 재정영향은 없을 것으로 예상됨.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 영국, 일본 등에 등재되어있음.

※ EMEA 허가사항에서는 rilpivirine은 초치료 환자에 있어 baseline viral load RNA ≤ 100,000 copies/mL인 경우 다른 항레트로바이러스 약제와 병용요법으로 사용하도록 되

어있음.

Reference

- 1) Harrison's Online, 18 ed, Internal Medicine
- 2) Principles and Practice of Clinical Virology, 6th ed.(2009), John Wiley & Sons Ltd.
- 3) Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in HIV-1-Infected Adults and Adolescents October 14, 2012, DHHS
- 4) Jean-Michel Molina et al. Rilpivirine versus efavirenz with tenofovir and emtricitabine in treatment-naïve adults infected with HIV-1 (ECHO): a phase 3 randomised double-blind active-controlled trial, Lancet 2011; 378(9787): 238-246
- 5) ITT-TLOVR outcome viral load <50 copies/mL
- 6) 어지러움, 비정상적인 꿈 또는 악몽, 오심, 발진
- 7) 두통, 집중 장애, 어지러움, 안면 신경마비, 시야 흐림 등
- 8) 비정상적인 꿈, 불안, 우울, 자살 충동, 성욕 감소 등
- 9) Calvin J Cohen et al, Rilpivirine versus efavirenz with two background nucleoside or nucleotide reverse transcriptase inhibitors in treatment-naïve adults infected with HIV-1 (THRIVE): a phase 3, randomised, non-inferiority trial, Lancet 2011; 378: 229-237
- 10) ECHO 임상시험과 동일
- 11) 불면, 두통, 오심, 어지러움, 발진
- 12) 두통, 집중 장애, 어지러움, 안면 신경마비, 시야 흐림 등
- 13) 비정상적인 꿈, 불안, 우울, 자살 충동, 성욕 감소 등
- 14) Rimsky L et al, Genotypic and phenotypic characterization of HIV-1 isolates obtained from patients on rilpivirine therapy experiencing virologic failure in the phase 3 ECHO and THRIVE studies: 48-week analysis. J Acquir Immune Defic Syndr. 2012 Jan 1;59(1):39-46
- 15) 대한감염학회()
- 16) 대한화학요법학회()
- 17) 2-1. 비교대상 선정, 비교대상을 선정함에 있어 비교할만한 등재 의약품이 있는 경우 이들 중 가장 많이 사용되는 것을 비교대상으로 함.
- 18) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 19) 대한화학요법학회()에서 제시한 대상환자수 기준, EDI 청구환자수() 상병으로 efavirenz, nevirapine을 청구한 환자수], 약 ()명)는 초치료 뿐 아니라 치료 경험이 있는 환자에게 사용한 경우도 포함되어 있으므로 학회에서 제시한 대상환자수를 기준으로 함.
- 20) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: 정, 2차년도: 정, 3차년도: 정)
- 21) 절대재정 = 예상 사용량 x 신청품 일일투약비용
- 22) 직전년도의 대체약제간 청구비중이 신청품 등재 전후의 청구비중과 동일하다고 가정함. 재정영향 = 예상 사용량 x (신청품 일일투약비용 - 대체약제 가중일일투약비용)
- 23) 제약사 제출 예상 사용량 (1차년도: 정, 2차년도: 정, 3차년도: 정)
- 24) 절대재정 = 예상 사용량 x 대체약제 가중일일투약비용